

Dolor pélvico musculoesquelético

Información para el paciente · Dolor pélvico que proviene de los músculos, las articulaciones y los nervios **WARWIKI**

Algunos dolores pélvicos no provienen de la vejiga ni de los órganos reproductivos, sino de los **músculos, las articulaciones, los nervios y el tejido conectivo** de la pelvis — a menudo un suelo pélvico tenso y demasiado activo que no se relaja. Esto es real, común y tratable, incluso cuando las ecografías y los análisis de laboratorio salen normales.

Acerca de esta afección

Los músculos del suelo pélvico pueden ponerse tensos o tener espasmos, igual que un músculo con un nudo en cualquier otra parte. Características comunes:

- Dolor, presión o ardor en la pelvis, el perineo, la parte baja de la espalda o las caderas
- Dolor al **sentarse**, con las relaciones sexuales (dispareunia), al usar tampones o al evacuar el intestino
- **Urgencia o frecuencia urinaria** causadas por los músculos tensos, y no por la vejiga en sí

Qué la causa

A menudo varias cosas juntas: tensión muscular o espasmos, una lesión previa, una cirugía o un parto, la postura y los hábitos, el estrés (que nos hace apretar) y, a veces, la irritación de un nervio pélvico. Con frecuencia se trata de un suelo pélvico “corto y tenso” más que débil — por eso los ejercicios de Kegel forzados pueden empeorarlo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Suelo pélvico

El grupo de músculos que sostiene los órganos pélvicos.

Suelo demasiado activo / tenso

Músculos que quedan apretados y no logran relajarse del todo.

Dispareunia

Dolor con la actividad sexual.

Punto gatillo

Un nudo muscular sensible que puede referir dolor a otra zona.

Fisioterapia del suelo pélvico

Terapia física que libera y reeduca estos músculos.

Reentrenamiento de relajación

Aprender a relajar (no a fortalecer) un suelo pélvico tenso.

Nervio pudendo

Un nervio pélvico que, al irritarse, puede causar dolor.

¿POR QUÉ MI PRUEBA ES NORMAL PERO SIGO CON DOLOR? Porque este dolor proviene de los músculos y los nervios, no de una infección o un crecimiento que aparezca en una ecografía. Una prueba normal es una buena noticia — señala un problema muscular tratable en lugar de algo peligroso. El dolor que no tiene una “imagen” sigue siendo muy real.

Cómo se diagnostica

- Una historia de dónde, cuándo y qué empeora el dolor
- Un examen que **revisa suavemente los músculos del suelo pélvico** para detectar sensibilidad y tensión
- Descartar otras causas (infección, etc.) con pruebas sencillas

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 La **fisioterapia del suelo pélvico** es la base — liberación manual, estiramientos y relajación (“reentrenamiento de relajación”).
- 2 **Autocuidado** — calor, movimiento suave, relajación/respiración, postura, y aliviar el estreñimiento y los irritantes de la vejiga.
- 3 **Medicamentos o inyecciones** — medicamentos para el dolor de nervios o inyecciones en los puntos gatillo.
- 4 **Atender el estrés y el sueño**, que influyen mucho en la tensión muscular.

Vivir con ello

- Note y suelte el **apretar** (mandíbula, glúteos, suelo pélvico) a lo largo del día.
- Use calor y estiramientos suaves; evite estar sentado mucho tiempo sobre superficies duras.
- El progreso suele ser gradual a lo largo de semanas de terapia — la constancia es importante.

Llame a su equipo si tiene:

- Dolor pélvico nuevo y **intenso**, o fiebre
- Cambios nuevos en el intestino o la vejiga, o entumecimiento/debilidad en las piernas
- Dolor después de una caída o lesión, o sangre en la orina o las heces

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El dolor pélvico a menudo proviene de músculos y nervios pélvicos tensos y demasiado activos — es real y tratable incluso cuando las pruebas salen normales.
2. La fisioterapia del suelo pélvico (para relajar, no para fortalecer) es el tratamiento principal, junto con el autocuidado, los medicamentos y el manejo del estrés.
3. La mejoría es gradual. Busque atención si tiene dolor nuevo e intenso, fiebre, entumecimiento/debilidad en las piernas o cambios en el intestino o la vejiga.